PROTOCOLO – ESTADOS HIPERGLICÊMICOS – CAD / EHH

Data: __ / __ / __ Idade: _____

Nome: _____ Prontuário: _____

TRIAGEM

- ✓ Náuseas, vômitos, desidratação
- ✓ Poliúria, polidipsia, polifagia
- ✓ Taquipneia, hálito cetônico
- ✓ Rebaixamento do nível de consciência
- ✓ Outros: Ex. Dor abdominal

\+ **GLICEMIA CAPILAR > 250 MG/DL**

SALA DE ESTABILIZAÇÃO – ATENDIMENTO PRIORITÁRIO COM GASOMETRIA ARTERIAL DE URGÊNCIA

ATENDIMENTO MÉDICO 1:

1. Solicitar exames iniciais:

( ) Glicemia plasmática
( ) Gasometria arterial (com lactato)
( ) Urina I **(avaliar cetonúria)**
( ) Sódio, fósforo, cloro e potássio

2. Critérios diagnósticos:

SÓDIO CORRIGIDO

Na^+ medido + 1,6 x $\frac{(glicemia-100)}{100}$

CAD	EEH
Glicemia > 250*	Glicemia > 600
pH < 7,3 ou Bicarbonato < 15	pH > 7,3
Cetonúria	Osmolaridade efetiva > 320 mOsm/kg

*Se em uso de iSGLT2: glicemia pode estar normal

OSMOLARIDADE EFETIVA

$2x\ (Na^+ \text{ corrigido}) + \frac{glicemia}{18}$

3. Solicitar exames complementares:

( ) Hemograma
( ) PCR
( ) Albumina **(cálculo AG)**
( ) Ureia, creatinina
( ) Triglicérides
( ) ECG, RX tórax

ATENDIMENTO MÉDICO 2 – SALA DE EMERGÊNCIA

- MANTER PACIENTE INICIALMENTE EM JEJUM
- SOLICITAR IC ENDOCRINOLOGIA

HIDRATAÇÃO

EXPANSÃO

1L a 1,5L SF 0,9% (15 – 20 ml/Kg) na 1ª hora

Se persistir hipotensão, considerar repetir expansão volêmica

Após, manter 500 mL a cada 1h até exames

INSULINOTERAPIA

1. Se $K^+ < 3,3$: NÃO iniciar insulina!

2. Se $K^+ > 3,3$: iniciar insulina regular EV 0,1 U/kg em bolus
+
*BIC a 0,1 UI/Kg/h

AFERIR GLICEMIA 1/1 H
Objetivo: Queda de glicemia de 50 – 70 mg/dl por hora

- Queda < 50 mg/dl/h: dobrar a taxa de infusão de insulina
- Queda > 50mg/dl/h: reduzir a taxa de infusão pela metade

POTÁSSIO

$K^+ < 3,3$: NÃO administrar insulina! Repor 20 a 40 mEq em 1h

1 amp KCL 19,1% = 25 mEq

K^+ entre 3,3 e 5,3: repor 20 a 30 mEq em cada litro de soro administrado

$K^+ > 5.3$: não repor e checar níveis de K^+ de 2/2h

BIC

pH < 6,9: Repor 100 mEq (100 ml) de BIC 8,4% + 400 ml de AD – Correr EV em 2h

pH ≥ 6,9: **NÃO repor BIC**

*** BOMBA DE INSULINA PADRONIZADA**
100 UI de insulina R em 100 ml de SF 0,9% (1 UI por ml)

Na^+ corrigido ≥ 135 → Manter NaCl 0,45%** 250 a 500 ml/h (4 – 14 ml/kg/h)

Na^+ corrigido < 135 → Manter SF 0,9% 250 a 500 ml/h (4 – 14 ml/kg/h)

**** SORO NACL 0,45% PADRONIZADO**
SF 0,9% 500ml + AD 500 ml = 1L de solução NaCl 0,45%

Quando glicemia atingir 250 mg/dl (CAD) ou 300 mg/dl (EHH):

- Prescrever SF 0,9% 500ml + SG 5-10% 500ml (250 – 500 ml/h)
- Reduzir bomba de insulina para 0,05 UI/kg/h

CRITÉRIOS DE RESOLUÇÃO

CAD	EHH
pH > 7,3	Osm < 310 mOsm/kg
BIC > 15mEq/l	Glicemia < 250mg/dl

APÓS RESOLUÇÃO

Iniciar dieta e MANTER bomba de insulina

Insulina regular 0,1 UI/kg subcutânea

SÓ DESLIGAR A BOMBA DE INSULINA 2H APÓS A REALIZAÇÃO DE INSULINA REGULAR SC

Manutenção de insulina: 0,5 UI/kg/dia divididas 3x ao dia (50% de NPH e 50% de regular)

Manter glicemia capilar de 6/6h (antes do café, almoço e jantar e às 22h)